

健康体检报告核心要素

体检日期	2026-06-04	在本机构一共体检次数 1
自测问卷发现的主要疾病及健康危险因素	手术史：心理压力过大或紧张： 药物过敏史：睡眠问题： 既往病史：	
检查结果	身高165.5cm 体重56.4kg 腰围76cm 臀围86cm 收缩压104mmHg 舒张压61mmHg 血红蛋白132g/L 白细胞4.54X10^9/L 血小板225X10^9/L 空腹血糖4.5mmol/L 总胆固醇4.66mmol/L 甘油三酯0.89mmol/L 低密度脂蛋白胆固醇2.39mmol/L 高密度脂蛋白胆固醇2.06mmol/L	
序号	主要健康问题(健康体检结论)	
1	右肺下叶磨玻璃结节，年度随访,双肺实性结节，陈旧灶可能	
2	(双侧)颈动脉斑块	
3	内痔	
4	(右侧)甲状腺多发胶质潴留	
5	前列腺增生 I °,前列腺增生伴钙化灶	
6	(左侧)肾结晶	
7	胱抑素C（cys C）增高:0.98 mg/L(正常值0.61-0.95)	

【体检结论和健康指导】

1. 右肺下叶磨玻璃结节, 年度随访, 双肺实性结节, 陈旧灶可能

[建议]: 建议定期复查胸部CT, 结合临床, 呼吸内科随访。

2. (双侧)颈动脉斑块

[建议]: 请血管外科就诊, 关注血压、血糖、血脂情况, 必要时药物治疗。定期复查颈动脉超声, 观察斑块大小及形态变化, 预防血栓栓塞。

3. 内痔

[建议]: 请养成每天定时排便的习惯, 多食蔬菜, 以保持大便通畅, 防止便秘, 忌烟酒辛辣刺激性食物, 多食新鲜水果、蔬菜及粗纤维食物; 必要时手术治疗。

4. (右侧)甲状腺多发胶质潴留

[建议]: 请定期复查甲状腺超声、甲状腺功能, 甲乳外科随访。

5. 前列腺增生 I°, 前列腺增生伴钙化灶

[建议]: 避免受凉和刺激性食物, 平时适当多饮水, 不要憋尿, 定期超声复查, 若有排尿不畅、尿不尽等症状请泌尿外科随访治疗。钙化灶建议定期复查随访。

6. (左侧)肾结晶

[建议]: (1)多饮水多运动, 少食含高钙、高糖、高嘌呤的食物。(2)定期复查肾脏B超, 必要时到泌尿外科诊治。

7. 胱抑素C (cys C) 增高:0.98 mg/L(正常值0.61-0.95)

[建议]: 与早期肾功能损害程度相关, 建议复查, 如仍高请到肾内科进一步诊治。

(其他各项检查均在正常范围之内或无重要临床意义。)

主检医师:

张叶丽

总检医师:

黄洁

杜绍荣



扫码查看影像

2026年06月10日

【各科室检查结果】

一般检查				
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
一般检查				
身高	165.5			cm
体重	56.4			kg
收缩压	104		90 - 140	mmHg
舒张压	61		60 - 90	mmHg
体重指数 (BMI)	20.6		18.5 - 23.9	
腰围	76		0 - 84.99	cm
臀围	86			cm
腰臀比	0.88		0 - 0.9	
检查所见: 未见明显异常				
检查者: 何倩雯				

内科	
内科 (检查)	
内科病史	未提及
肺部	未见明显异常
心脏	未见明显异常
肝脏	肋下未触及
脾脏	肋下未触及
内科其他	无
检查所见: 未见明显异常	
检查医生: 张叶丽	

外科	
男外科检查	
外科病史	未提及
皮肤	未见明显异常
浅表淋巴结	未见明显异常
甲状腺	未见明显异常
乳房	未见明显异常
脊柱	未见明显异常
四肢关节	未见明显异常

男性外生殖器	未见明显异常
肛门及直肠指诊	前列腺正中沟消失，表面光滑有韧感，无压痛，前列腺似鸽蛋大小。肛门口可见柔软的紫红色包块。
下肢静脉	未见明显异常
外科其他检查	无
检查所见:	前列腺增生 I°；内痔
检查医生: 张浩	

眼科				
眼科检查				
视力	裸眼：右眼：5.0/1.0 左眼：5.0/1.0			
色觉	正常			
外眼	未见明显异常			
裂隙灯检查	未见明显异常			
眼底检查	未见明显异常			
检查所见：	未见明显异常			
检查者：赵敏				
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
非接触眼压检查				
右眼眼压	11		10 - 21	mmHg
左眼眼压	11		10 - 21	mmHg
检查所见：	未见明显异常			
检查者：赵敏				

耳鼻喉科	
耳鼻喉科检查	
听力	未见明显异常
耳廓	未见明显异常
外耳道	未见明显异常
鼓膜	未见明显异常
外鼻	未见明显异常
鼻腔	未见明显异常
口咽	未见明显异常
检查所见:	未见明显异常
检查医生: 徐冰清	

超声科	
颈动脉彩超	
颈动脉超声	双侧颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉及椎动脉管径内径正常；双侧颈动脉内膜光滑，于左侧颈总动脉可见多个低回声附着，较大范围约0.8×0.22cm,右侧颈总动脉可见多个低回声附着，较大范围约1.9×0.34cm,表面欠光滑，未至管腔明显狭窄。CDFI显示血流方向正常，管腔内血流信号充盈满意。
超声所见:	(双侧)颈动脉斑块
记录护士:	张灿
检查医生:	李剑
彩色多普勒超声常规检查（肝胆胰脾）	
肝脏超声	肝脏大小形态正常，包膜光滑，边缘锐利，实质回声均匀，肝内管道结构清晰，走行正常，肝内未见明显异常回声。
胆囊超声	胆囊大小形态正常，壁不厚，光滑，腔内未见明显异常回声，胆总管未见扩张。
胰腺超声	胰腺大小形态正常，回声均匀，胰管不宽，因气体干扰胰尾显示不清。
脾脏超声	脾脏大小形态正常，实质回声均匀，内未见明显异常回声。
超声所见:	肝胆胰脾未见明显异常
记录护士:	张灿
检查医生:	李剑
彩色多普勒超声常规检查（泌尿系男）	
肾脏超声	双肾大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，双肾集合系统不分离，左肾盂内可见数个点状强回声，后不伴声影。
输尿管超声	双侧输尿管未见明显扩张。
膀胱超声	膀胱未充盈。
前列腺超声	前列腺大小约4.4cm×4.2cm×3.9cm，形态饱满，包膜光滑，腺体内见一强回声斑。
超声所见:	(左侧)肾结晶；前列腺增生伴钙化灶
记录护士:	张灿
检查医生:	李剑
浅表器官多普勒超声（甲状腺及颈部淋巴）	

甲状腺超声	双侧甲状腺大小正常，包膜光滑，形态规则，峡部不厚；右侧腺体实质内见数个无回声结节，大的约0.2cm×0.2cm，内可见点状强回声，CDFI：结节周边及内部未见异常血流信号；甲状腺及甲状旁腺周围未见异常淋巴结回声。		
超声所见：	(右侧)甲状腺多发胶质潴留		
记录护士：	张灿	检查医生：李剑	

心电图室			
电脑多导联心电图			
检查所见：	正常范围心电图		
检查护士：	韩慧婷	审核医生：黄新苗/任秀娟	

CT室			
低剂量胸部CT平扫			
低剂量胸部CT平扫	双侧胸廓对称，双肺野纹理清晰，右肺下叶（IM222）见磨玻璃结节影，大小约4mm×3mm。右肺上叶（IM59）、右肺下叶（IM254）、左肺斜裂（IM139）见多发实性结节影，长径范围约4-6mm，较大者大小约6mm×4mm，位于右肺下叶前基底段。气管及主要支气管通畅。纵隔居中，纵隔、肺门未见明显肿大淋巴结影。胸腔未见明显积液征象。双侧胸膜未见明显增厚。		
报告所示：	右肺下叶磨玻璃结节，年度随访；双肺实性结节，陈旧灶可能		
报告医生：	金韵	审核医生：田冰	

检验科 [此结果仅对送检标本负责]				
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
血常规				
白细胞计数（WBC）	4.54		3.5 - 9.5	10 ⁹ /L
红细胞计数（RBC）	4.44		4.3 - 5.8	10 ¹² /L
血红蛋白含量（Hb）	132		130 - 175	g/L
红细胞比积（HCT）	42.10		40 - 50	%
平均红细胞体积（MCV）	94.8		82 - 100	fL
平均红细胞血红蛋白含量（MCH）	29.7		27 - 34	pg
平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）	314	↓	316 - 354	g/L

血小板计数 (PLT)	225	125 - 350	10 ⁹ /L
红细胞分布宽度标准差 (RDW-SD)	43.8	37 - 54	fL
红细胞分布宽度变异系数 (CV)	12.5	11.9 - 14.5	%
血小板分布宽度 (PDW)	11.50	9.8 - 16.1	fL
平均血小板体积 (MPV)	9.90	9.4 - 12.6	fL
大血小板比率 (P-LCR)	24.7	19.2 - 47	%
血小板压积 (PCT)	0.22	0.16 - 0.35	%
中性粒细胞绝对值 (Neut#)	2.55	1.8 - 6.3	10 ⁹ /L
淋巴细胞绝对值 (Lymph#)	1.48	1.1 - 3.2	10 ⁹ /L
单核细胞绝对值 (Mono#)	0.33	0.1 - 0.6	10 ⁹ /L
嗜酸性粒细胞绝对值 (Eos#)	0.15	0.02 - 0.52	10 ⁹ /L
嗜碱性粒细胞绝对值 (Baso#)	0.03	0 - 0.06	10 ⁹ /L
中性粒细胞百分比 (Neut%)	56.1	40 - 75	%
淋巴细胞百分比 (Lymph%)	32.6	20 - 50	%
单核细胞百分比 (Mono%)	7.3	3 - 10	%
嗜酸性粒细胞百分比 (Eos%)	3.3	0.4 - 8	%
嗜碱性粒细胞百分比 (Baso%)	0.7	0 - 1	%

检验者: 范佳慧子

审核者: 朱俊

检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
尿常规 (专用)				
尿镜检上皮细胞	未见异常			
尿镜检管型	未见异常			
尿检查其它	未见异常			

尿葡萄糖 (GLU)	阴性(-)	-
尿白细胞酯酶	阴性(-)	-
尿胆原 (URO)	阴性(-)	Normal
尿亚硝酸盐 (NIT)	阴性(-)	-
尿隐血 (BLD)	阴性(-)	-
尿蛋白质 (PRO)	阴性(-)	-
尿维生素C (Vitc)	阳性(3+)	
尿酮体 (KET)	阴性(-)	-
尿胆红素 (BIL)	阴性(-)	-
尿镜检红细胞	未见异常	未见异常
尿镜检白细胞	未见异常	未见异常
尿酸碱度 (PH)	5.0	5 - 9
尿比重 (SG)	1.030	1.005 - 1.03

检验者: 王倩

审核者: 朱俊

便常规

粪便颜色	黄色
粪便性状	软
粪便镜检红细胞	未查见
粪便镜检白细胞	未查见
粪便镜检虫卵	未查见
粪便镜检其它	未查见

检验者: 王倩

审核者: 朱俊

粪便隐(免疫法)

粪便隐血实验 (FOBT)	阴性
---------------	----

检验者: 王倩

审核者: 朱俊

检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
空腹血糖 (GLU)	4.5		3.9 - 6.1	mmol/L

检验者: 黄乔莹

审核者: 朱俊

检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
肝功能全套				
丙氨酸氨基转移酶 (ALT)	20		9 - 50	U/L
门冬氨酸氨基转移酶 (AST)	18		15 - 40	U/L
γ-谷氨酰转移酶 (γ-GT)	46		10 - 60	U/L
碱性磷酸酶 (ALP)	71		45 - 125	U/L

乳酸脱氢酶 (LDH)	180	120 - 250	U/L
总胆红素 (TBIL)	9.2	0 - 23	μmol/L
直接胆红素 (DBIL)	4.0	0 - 8	μmol/L
间接胆红素 (IDBIL)	5.2	0 - 15	μmol/L
总蛋白 (TP)	70	65 - 85	g/L
白蛋白 (ALB)	48	40 - 55	g/L
球蛋白 (GLO)	22	20 - 40	g/L
白球比 (A/G)	2.18	1.2 - 2.4	
前白蛋白 (PA)	369	200 - 430	mg/L
总胆汁酸 (TBA)	2.4	0 - 9.99	μmol/L

检验者: 黄乔莹

审核者: 朱俊

检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
尿微量白蛋白				
尿微量白蛋白	6.50			

检验者: 黄乔莹

审核者: 朱俊

检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
血脂四项				
甘油三酯 (TG)	0.89		0 - 1.69	mmol/L
总胆固醇 (TC)	4.66		0 - 5.19	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)	2.06	↑	1.16 - 1.42	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)	2.39		0 - 3.39	mmol/L

检验者: 黄乔莹

审核者: 朱俊

检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
甲功七项				
促甲状腺激素 (TSH)	2.330		0.27 - 4.2	mIU/L
三碘甲状腺原氨酸 (T3)	1.5		1.3 - 3.1	nmol/L
甲状腺素 (T4)	92.0		66 - 181	nmol/L
游离甲状腺素 (fT4)	14.300		12 - 22	pmol/L
游离三碘甲状腺原氨酸 (fT3)	4.870		3.1 - 6.8	pmol/L
抗甲状腺球蛋白抗体 (TGAb)	20.0		0 - 114.99	IU/ml
抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb)	14.7		0 - 33.99	IU/ml

检验者: 唐玉洁		审核者: 朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
甲胎蛋白 (AFP)				
甲胎蛋白(AFP)	4.98		0 - 20	ng/ml
检验者: 唐玉洁		审核者: 朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
癌胚抗原 (CEA)				
癌胚抗原 (CEA)	1.43		0 - 5	ng/ml
检验者: 唐玉洁		审核者: 朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
糖链抗原19-9				
糖链抗原19-9 (CA19-9)	7.82		0 - 39	U/ml
检验者: 唐玉洁		审核者: 朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
糖链抗原242				
糖链抗原242 (CA242)	4.01		0 - 25	kU/L
检验者: 朱嘉仪		审核者: 朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
前列腺肿标二项				
总前列腺特异性抗原 (TPSA)	1.030		0 - 4	ng/ml
游离前列腺特异性抗原 (F-PSA)	0.297			ng/ml
F-PSA/TPSA	0.288		0.25 - 1	
检验者: 唐玉洁		审核者: 朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
丙肝抗体定量检测				
丙型肝炎病毒抗体定量 (HCV-Ab)	0.048		0 - 1	COI
检验者: 唐玉洁		审核者: 朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
血沉				
血沉	12.00		0 - 15	mm/h
检验者: 范佳慧子		审核者: 朱俊		

检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
心肌酶谱二项				
肌酸激酶（CK）	158		50 - 310	U/L
肌酸激酶同工酶（CK-MB）	13.8		0 - 25	U/L
检验者：黄乔莹		审核者：朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
神经特异性烯醇化酶				
神经特异性烯醇化酶（NSE）	9.720		0 - 17	ng/ml
检验者：唐玉洁		审核者：朱俊		
艾滋病病毒抗体检测				
艾滋病病毒抗体（Anti-HIV）	阴性(-)		阴性(-)	
检验者：唐玉洁		审核者：朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
细胞角蛋白19片段				
细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）	2.81		0 - 3.3	ng/ml
检验者：唐玉洁		审核者：朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
同型半胱氨酸				
同型半胱氨酸（HCY）	9.8	↓	12 - 15	μmol/L
检验者：黄乔莹		审核者：朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
尿肌酐				
尿肌酐	13.97			
尿微量白蛋白/尿肌酐	0.465		0 - 2.26	
检验者：黄乔莹		审核者：朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
电解质七项				
钠（Na）	143		137 - 147	mmol/L
钾（K）	4.1		3.5 - 5.3	mmol/L
氯（Cl）	105		99 - 110	mmol/L
磷（P）	1.13		0.85 - 1.51	mmol/L

镁（Mg）	0.95		0.75 - 1.02	mmol/L
钙（Ca）	2.39		2.11 - 2.52	mmol/L
铁（Fe）	17.71		10.6 - 36.7	μmol/L
检验者：黄乔莹		审核者：朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
糖化血红蛋白				
糖化血红蛋白（HBA1C）	5.8		3.6 - 6	%
检验者：范佳慧子		审核者：朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
肾功四项				
肌酐（Cre）	99			μmol/L
尿素（UREA）	6.9			mmol/L
尿酸（UA）	338		208 - 428	μmol/L
胱抑素C（cyc C）	0.98	↑	0.61 - 0.95	mg/L
检验者：黄乔莹		审核者：朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
糖类抗原50				
糖链抗原50（CA50）	5.293		0 - 25	U/ml
检验者：朱嘉仪		审核者：朱俊		
梅毒螺旋体抗体（化学发光法）				
梅毒螺旋体抗体	阴性(-)		阴性(-)	
检验者：唐玉洁		审核者：朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
鳞癌相关抗原化学发光法（SCC）				
鳞状上皮细胞癌相关抗原（SCC）	0.56		0 - 1.5	ng/ml
检验者：朱嘉仪		审核者：朱俊		
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
凝血四项（送检验科）				
凝血酶原活动度（PTA）	103.3		70 - 130	%
国际标准化比值（INR）	0.95		0.82 - 1.15	
部分凝血酶原时间（APTT）	25.0		22 - 36	s
纤维蛋白原（FIB）	3.01		1.8 - 3.5	g/L
凝血酶时间（TT）	16.6		14 - 21	s

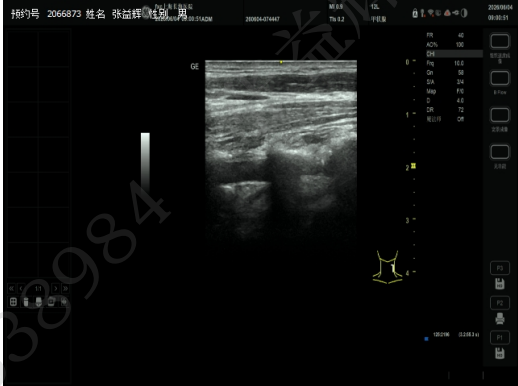
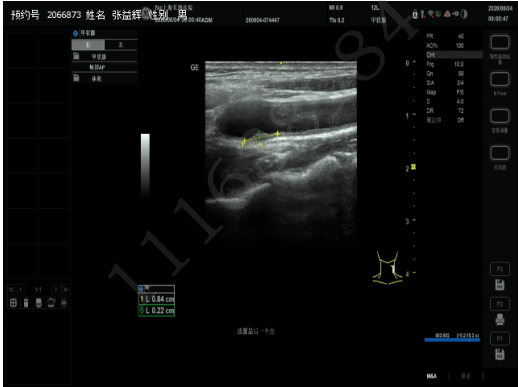
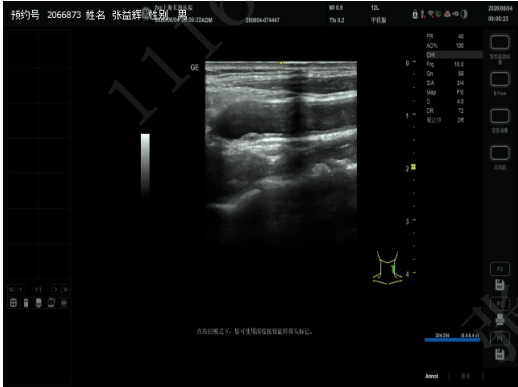
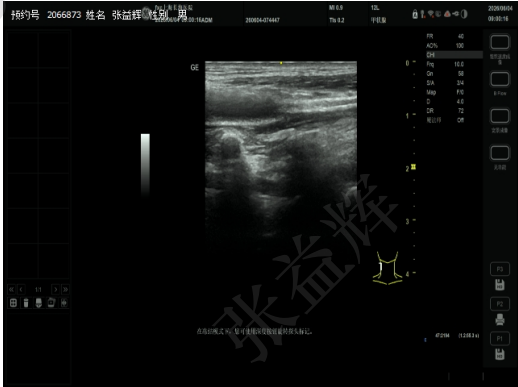
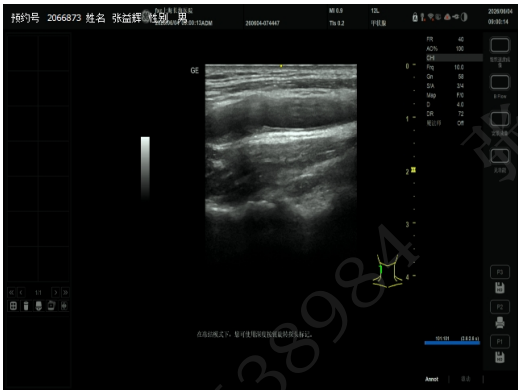
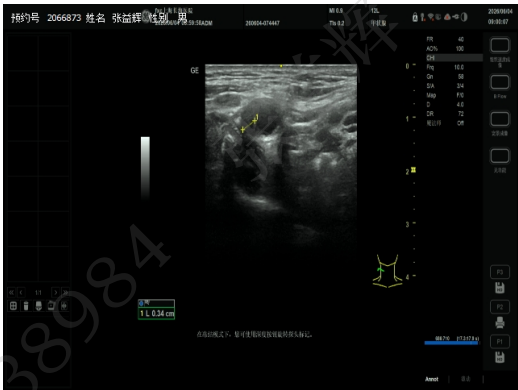
姓名:张益辉 性别:男 年龄:59 预约号:2066873 上海长海医院健康管理中心

凝血酶原时间 (PT)	11.2	9.8 - 12.7	s
检验者:	孙璇	审核者:	朱荣荣

碳13				
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
碳13呼气试验				
碳13呼气试验	2.2		0 - 4	
检查所见:	阴性			
		医生: 张叶丽		

超声科影像报告

颈动脉彩超

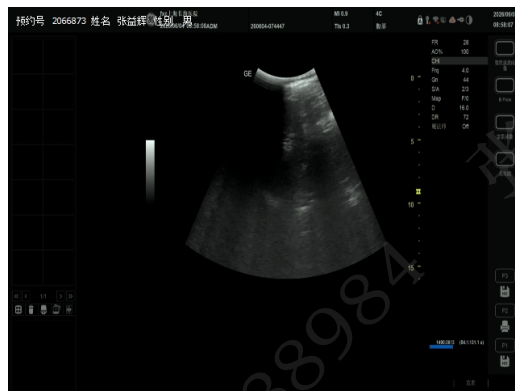
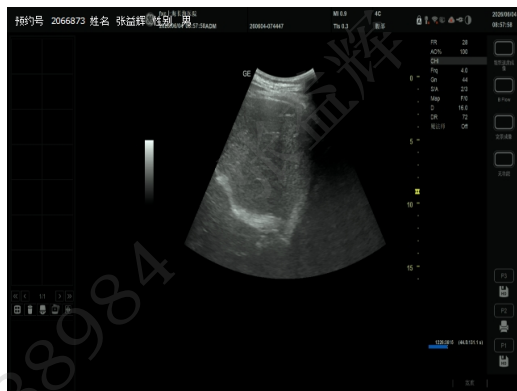
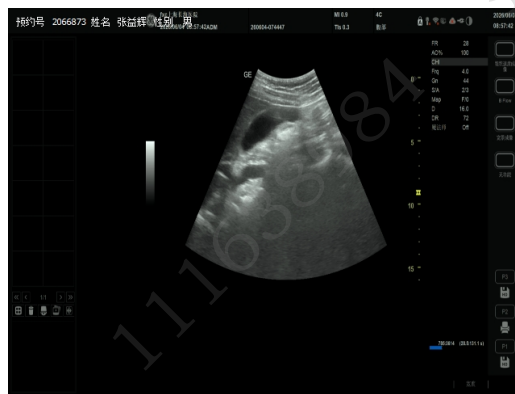
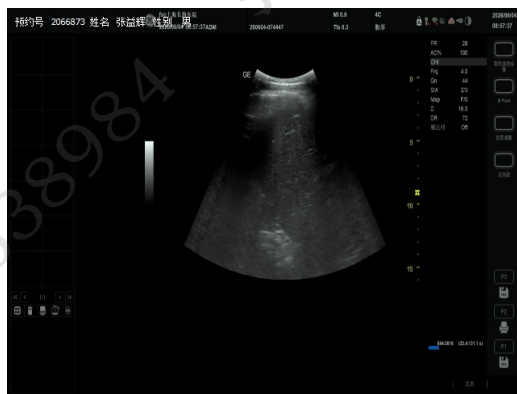
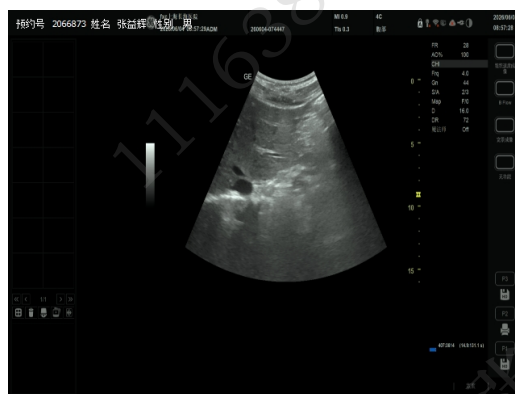
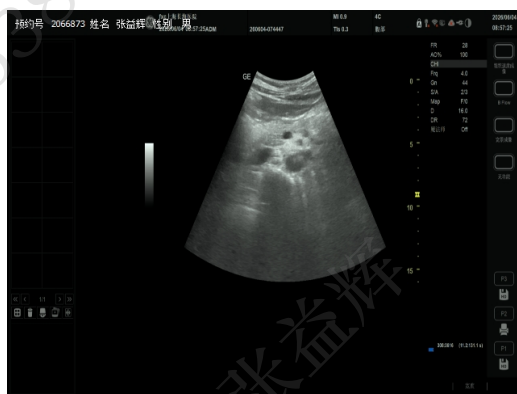
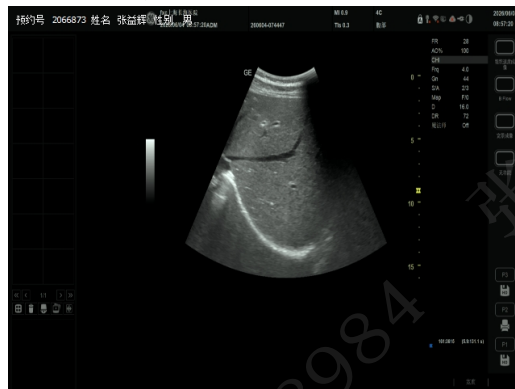
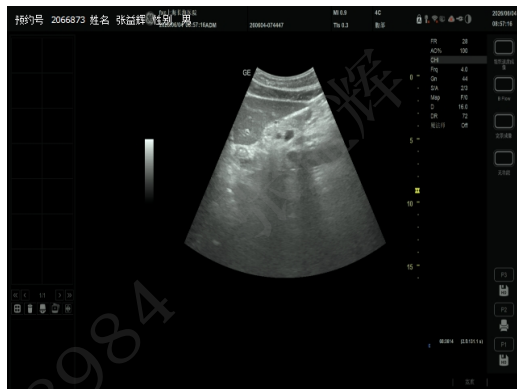


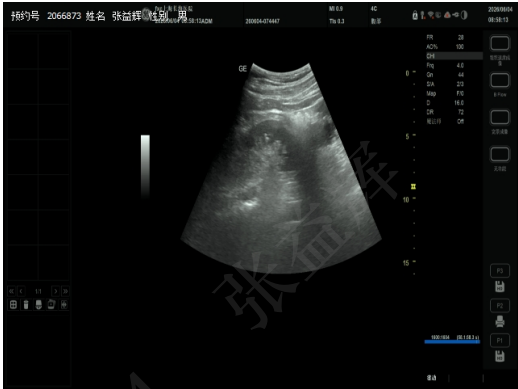
超声所见:

颈动脉超声: 双侧颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉及椎动脉管径内径正常; 双侧颈动脉内膜光滑, 于左侧颈总动脉可见多个低回声附着, 较大范围约 $0.8 \times 0.22\text{cm}$, 右侧颈总动脉可见多个低回声附着, 较大范围约 $1.9 \times 0.34\text{cm}$, 表面欠光滑, 未至管腔明显狭窄。CDFI显示血流方向正常, 管腔内血流信号充盈满意。

超声提示: (双侧)颈动脉斑块

彩色多普勒超声常规检查（肝胆胰脾）



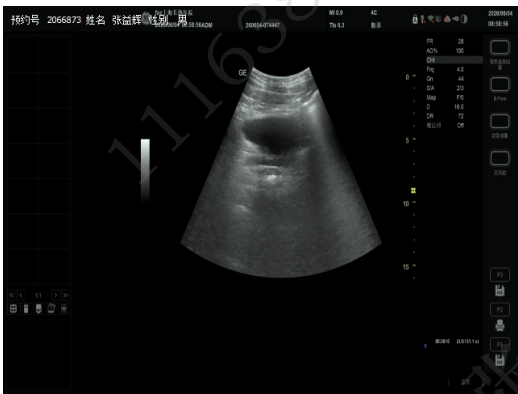
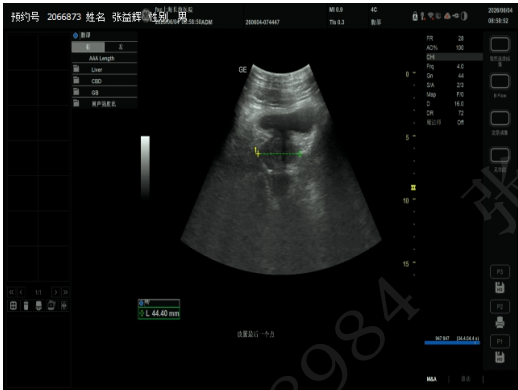
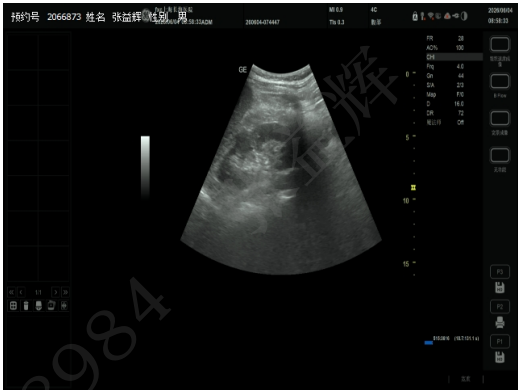


超声所见:

- 胆囊超声: 胆囊大小形态正常, 壁不厚, 光滑, 腔内未见明显异常回声, 胆总管未见扩张。
- 肝脏超声: 肝脏大小形态正常, 包膜光滑, 边缘锐利, 实质回声均匀, 肝内管道结构清晰, 走行正常, 肝内未见明显异常回声。
- 脾脏超声: 脾脏大小形态正常, 实质回声均匀, 内未见明显异常回声。
- 胰腺超声: 胰腺大小形态正常, 回声均匀, 胰管不宽, 因气体干扰胰尾显示不清。

超声提示: 肝胆胰脾未见明显异常

彩色多普勒超声常规检查（泌尿系男）

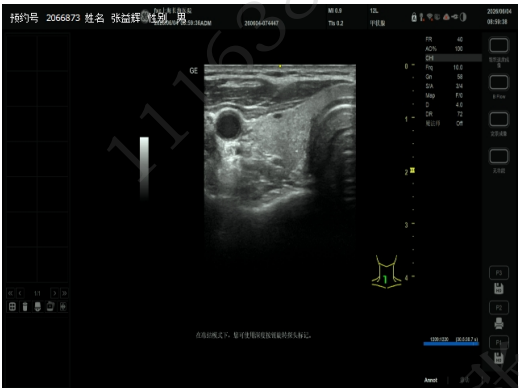
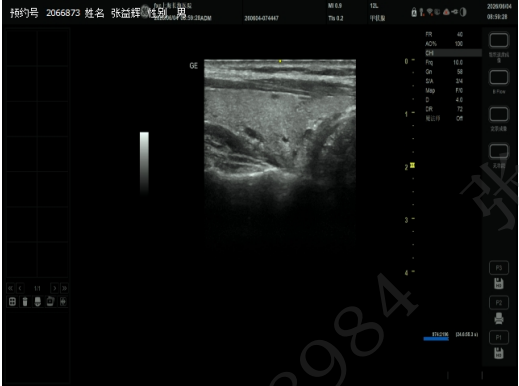
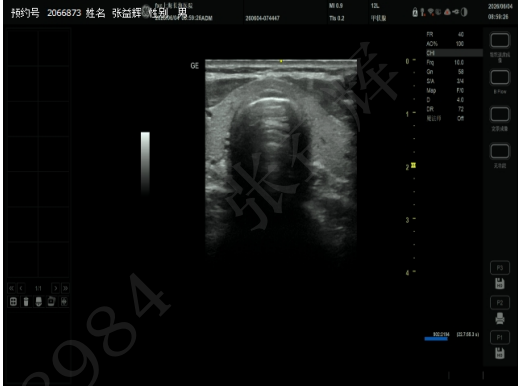


超声所见:

- 膀胱超声: 膀胱未充盈。
- 前列腺超声: 前列腺大小约4.4cm×4.2cm×3.9cm，形态饱满，包膜光滑，腺体内见一强回声斑。
- 肾脏超声: 双肾大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，双肾集合系统不分离，左肾盂内可见数个点状强回声，后不伴声影。
- 输尿管超声: 双侧输尿管未见明显扩张。

超声提示: (左侧)肾结晶; 前列腺增生伴钙化灶

浅表器官多普勒超声（甲状腺及颈部淋巴）



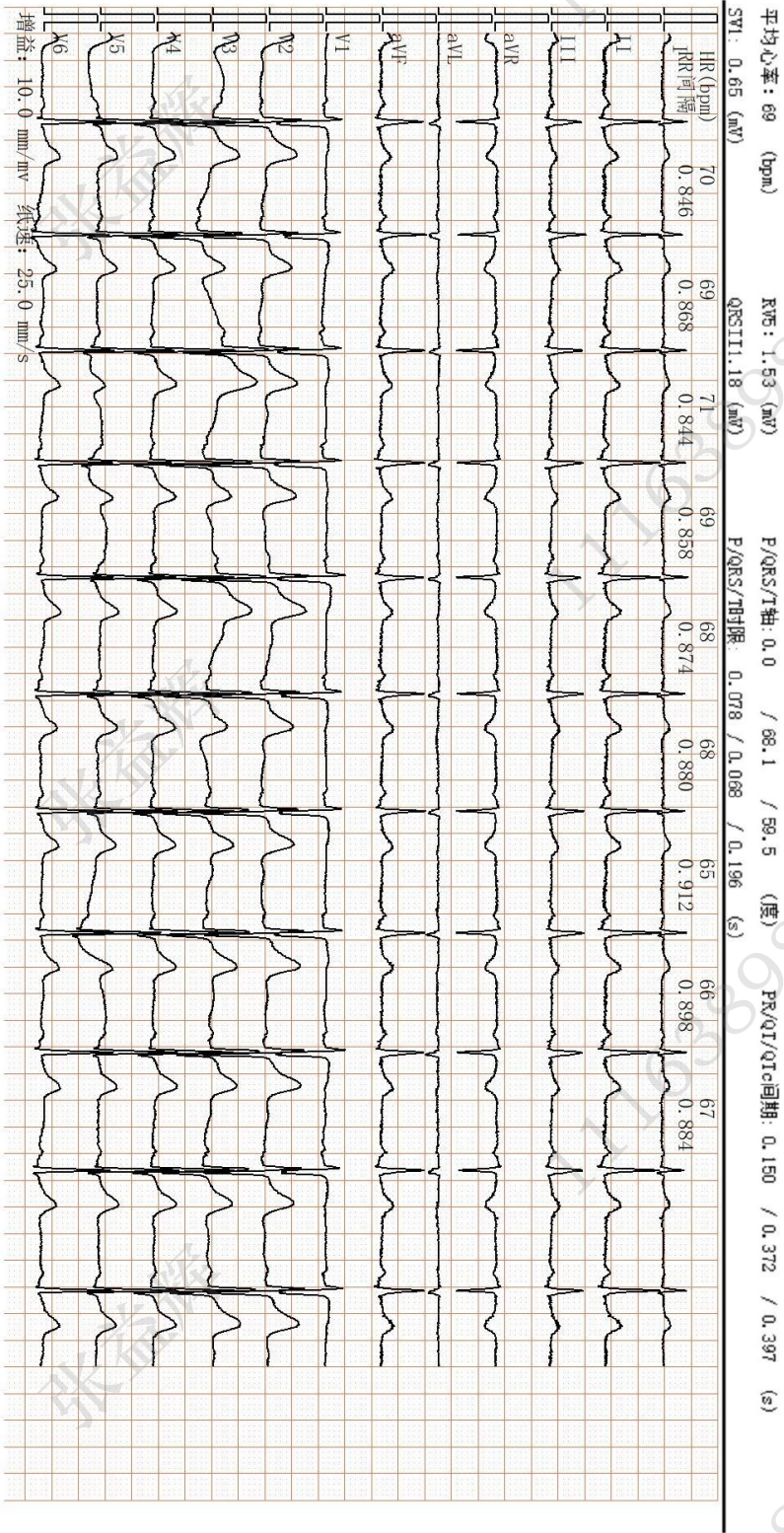
超声所见：
甲状腺超声： 双侧甲状腺大小正常，包膜光滑，形态规则，峡部不厚；右侧腺体实质内见数个无回声结节，大的约0.2cm×0.2cm，内可见点状强回声，CDFI：结节周边及内部未见异常血流信号；甲状腺及甲状旁腺周围未见异常淋巴结回声。

超声提示： (右侧)甲状腺多发胶质潴留

(以上意见仅供临床医生参考，不作医疗证明)

上海长海医院健康管理中心
常规心电图检查报告单

姓名:张益辉 性别:男 年龄:59岁 病人编号:2066873



心电图诊断: 正常范围心电图

检查者: 韩慧婷 报告医师: 黄新苗/任
检查时间: 2026/6/4 9:13:50 报告时间: 2026/6/4

注:本报告仅供临床参考,不作任何证明.

检验科				
检查项目	本次结果	上次结果	参考值	单位
乙肝五项定量检测				
乙肝表面抗原（HBsAg）	0.406		0 - 1	COI
乙肝表面抗体（HBsAb）	346.000 ↑		0 - 10	IU/L
乙肝e抗原（HBeAg）	0.092		0 - 1	COI
乙肝e抗体（HBeAb）	0.222 ↓		1 - 100000	COI
乙肝核心抗体（HBcAb）	0.007 ↓		1 - 10000	COI
审核者：朱俊		检验者：唐玉洁		

序号	表面抗原	表面抗体	e抗原	e抗体	核心抗体	乙肝两对半常见结果分析
1	-	-	-	-	-	既往和现在均未感染过HBV。
2	+	-	-	-	-	急性HBV感染潜的伏期后期。
3	+	-	+	-	+	急性或慢性乙肝，提示HBV处于复制，传染性强，俗称“乙肝大三阳”。
4	+	-	-	+	+	急性HBV感染趋向恢复，或慢性HBsAg携带者，传染性相对较弱，俗称“乙肝小三阳”。
5	+	-	+	-	-	急性HBV感染早期，或慢性HBsAg携带者，传染性强。
6	+	-	+	+	+	急性HBV感染趋向恢复，或慢性HBsAg携带者。
7	+	-	-	+	-	急性HBV感染趋向恢复，或慢性HBsAg携带者易转阴。
8	+	-	-	-	+	急性HBV感染，或慢性HBsAg携带者，传染性弱。
9	-	-	-	+	+	急性HBV感染恢复期，或既往感染过HBV，少数标本仍有传染性。
10	-	-	-	-	+	既往HBV感染未能测出抗-HBs，或感染恢复期表面抗原已消失，乙肝表面抗体尚未出现。
11	-	+	-	+	+	既往感染过HBV，已清除，且已出现保护性抗体。
12	-	+	-	-	+	接种过乙肝疫苗，或HBV感染后已康复，有免疫力。
13	-	+	-	-	-	接种过乙肝疫苗有抗体，或既往HBV感染过，有免疫力。

14	乙肝HBV-DNA定量阳性	(1) 评估传染性高低	提示乙肝病毒在复制，具有传染性，且数值越大，病毒复制越活跃，传染性越强。
		(2) 判断药物的疗效	乙肝抗病毒药物可以抑制乙肝病毒的复制。如果在用药后乙肝DNA定量结果逐渐下降，则表明该药的治疗是有效果的。建议进一步肝功能全套、肝纤维化四项、GP73肝癌三项、腹部彩超、肝脏MRI平扫+增强等检查。



在线就诊操作流程

— 面向医保、大病医保、异地慢特病、自费等各类人员 —



1

扫描二维码
进入互联网医院



健康长相随
四海皆可及

2

绑定就诊卡

3

选择对应科室
预约挂号

4

线上沟通诊疗
医生根据病情开具药品处方
或检查检验申请单

5

完成支付

自助预约检查

上海长海医院互联网医院



四大功能模块

在线服务

普通门诊、专家/特需门诊
特色门诊（训练伤等）、团队门诊

快捷服务

快速配药、订单中心、查看药品、检验检查等

住院服务

住院证查询
自助办理入院等

个人中心

报告查询、物流查询、预约检查咨询等

优质医疗乘“云”直上 长海医院触手可及

温馨提示

支付药品处方时，领取方式若选择“配送到家”需准确填写收货地址和联系电话；若选择“自提”，系统自动生成取药二维码作为线下取药凭证。

客服热线

185 0210 7080